

Il Corpo Deformato — Disturbi del Comportamento Alimentare · Schema

Salute Mentale · Sessione 11

Cibo: Valore Simbolico e Relazionale

- **Primo mediatore relazionale** → il neonato incontra il mondo attraverso l'alimentazione
 - **Prefigura le relazioni future** → modalità del nutrimento = prima esperienza affettiva
 - **Gusto** → elaborato da cervello, memoria (ippocampo), emozioni (amigdala) — **mai neutro**
 - **Identità culturale** → cibo come confine tra sé e l'altro, tra gruppi sociali
 - **Tendenza attuale** → pasto da momento di unione a divisione (Niola, 2015: "tribù alimentari")
-

Classificazione DNA — DSM-5-TR

DNA = Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione

Disturbo	Caratteristica	Età
Pica	Ingestione di non-alimenti	Infanzia
Ruminazione	Rigurgito automatico	Infanzia
Evitante/ restrittivo	Alimentazione selettiva, fobia del nuovo	Infanzia
Anoressia nervosa	Restrizione + paura peso + distorsione immagine	Adolescenza+

Disturbo	Caratteristica	Età
Bulimia nervosa	Abbuffate + compensatori	Adolescenza+
BED	Abbuffate senza compensazione	Adulti

- **BED** riconosciuto come entità autonoma nel DSM-5 → **2013**
- Quadri puri sempre meno frequenti → prevalgono forme miste e sindromi sottosoglia

Anoressia Nervosa — Criteri

- **Restrizione calorica** → peso < minimo normale
- **Paura intensa** di ingrassare (o comportamenti che impediscono l'aumento di peso)
- **Distorsione immagine corporea** → peso/forma influenzano eccessivamente l'autostima
- Sottotipi: **restrittivo** (solo dieta/esercizio) | **con abbuffate/eliminazione**
- BMI < 17 → criterio indicativo di gravità

Bulimia Nervosa — Criteri

- **Abbuffate ricorrenti** → quantità eccessiva + perdita di controllo
- **Comportamenti compensatori** → vomito (80%), lassativi, diuretici, digiuno, esercizio
- Frequenza minima: 1 episodio/settimana per 3 mesi
- **Autovalutazione** indebitamente influenzata da forma e peso
- **Non necessariamente sottopeso**

BED — Caratteristiche

- Abbuffate + perdita di controllo (come bulimia)
 - **No** comportamenti compensatori sistematici
 - Mangiare in solitudine, con vergogna, disgusto, senso di colpa
-

Evoluzione Storica (Cosenza, 2008)

Periodo	Caratteristiche
Anni '60 "Mosche bianche"	Prime anoressiche negli ospedali; sintomo solo restrittivo
Anni '70 "Malattia d'élite"	Classe borghese; diffusione USA→Europa→Giappone (Bruch)
Anni '80-'90	Compagno abbuffate + evacuazione; si estende alle classi popolari
Anni 2000+	Poliabuso; globalizzazione; siti pro-ana; identità costruita sul sintomo

Scissione Mente-Corpo

- **Selvini-Palazzoli** (1963) → paura del **corpo**, non del cibo
- Il corpo pubere diventa **persecutorio** → si avvicina al corpo della madre → difficoltà separazione
- **Funzione autarchica** → illusione di vivere senza apporti esterni
- I DCA → **patologie narcisistiche**
- **Mito Eco e Narciso** → **impossibilità comunicativa + investimento narcisistico sul corpo**

DCA Come Disturbi Etnici

Devereux (1978) → *Culture-Bound Syndrome* (disturbo etnico)

Criteri di un disturbo etnico: - Frequente nella cultura specifica - Continuità tra elementi normali della cultura e sintomi (esagerazione di comportamenti positivi) - Esprime i conflitti fondamentali della società - Offre un "modello di cattiva condotta" socialmente strutturato

Esempi: Amok (Malesia) · Windigo (Canada) · Cane Pazzo (Crow) · **Anoressia/bulimia (Occidente)**

Distinzione fondamentale: - **Cultura = fattore patoplastico (Jaspers)** → plasma la **forma** della sofferenza, non ne è la causa - Non: "la moda causa l'anoressia" - **Sì: "chi ha una vulnerabilità psichica si ammala; la cultura indica in quale forma"**

Ortoressia e Vigoressia

Ortoressia

- **orthos + orexis** → **ossessione per il "mangiare sano"**
- Controllo sulla **qualità** (non quantità)
- Evita socialità legata al cibo → porta i propri cibi ovunque
- Non ancora nel DSM → in forte aumento post-COVID
- **Rischio: intolleranze auto-diagnosticate → diete sempre più restrittive (Dalla Ragione)**

Vigoressia (Muscle Dysmorphia)

- **"Anoressia inversa"** (Pope, 1993) → mai abbastanza muscolosi
- Dismorfismo corporeo speculare all'anoressia
- Prevalente nei maschi, in espansione tra adolescenti
- Dimagrimento = effetto secondario, non obiettivo

Confronto AN vs Ort/Vig

	Anoressia	Ortoressia/Vigoressia
Obiettivo	Dimagrimento	Autocontrollo fine a sé stesso
Cibo	Repulsione	Controllo qualità (non repulsione)
Dismorfismo	Sì (si vede grassa)	Non sempre presente
Peso	Sottopeso grave	Variabile

	Anoressia	Ortoressia/Vigoressia
Identità	Rifiuto corpo pubere	Corpo forte, vincente, sano

Eziologia Multifattoriale

Fattori Predisponenti

- Genetici → personalità ossessiva/perfezionista; predisposizione obesità infantile
- Psicologici → bassa autostima, instabilità dell'umore
- Familiari → modello alimentare della madre; commenti critici sul peso; abuso di sostanze in famiglia
- Socioculturali → ideale di magrezza come pressione normativa

Fattori Precipitanti

- Lutti, separazioni, aggressioni
- Fallimenti scolastici, cambio scuola, prese in giro per l'aspetto
- Traumi sessuali (fattore di rischio non specifico)
- Problemi interpersonali + bassa autostima

Fattori Cronicizzanti

- Digiuno prolungato → spinta biologica crescente al cibo
 - Fattori cognitivi → difficoltà concentrazione, mancata presa di coscienza
 - Alterazioni fisiche → esofago, cuore, ossa, sistema ormonale
 - Distorsione immagine corporea → continua a vedersi grassa → continua a dimagrire
 - Dinamiche familiari → perpetuano le stesse condizioni
-

Aspetti Psicodinamici

- **Separazione-individuazione** (Mahler) → difficoltà nei primi 2-3 anni = fattore predisponente
 - **Bruch** → "bambine perfette" con bisogni non riconosciuti → **falso sé compiacente**
 - **Il sintomo alimentare** → **unico spazio di autonomia e controllo**
 - **Dialettica dipendenza/autonomia:**
 - Abbuffata → riempire il vuoto (dipendenza)
 - Vomito → spingere via (autonomia)
 - Restrizione → illusione di bastare a sé stessi
 - **Identità liquida** → **il sintomo offre un'identità chiara e stabile (disfunzionale)**
-

Immagine Corporea e Dispercezione

- **Dispercezione corporea** → errore nella stima del proprio corpo (percettivo + affettivo)
 - **Tecnica terapeutica:** far disegnare l'immagine percepita → sovrapporre il contorno reale
 - **Scissione mente-corpo grave** → corpo vissuto come nemico → rischio ideazione suicidaria
-

Per il Lavoro Sociale

- **Non gestire l'alimentazione direttamente** → presa in carico multidisciplinare
 - Costruire relazione senza forzare sul tema del cibo
 - Temi centrali: relazionali e affettivi
 - Coinvolgimento della famiglia → fondamentale
 - **Ricadute** → parte del processo, non sconfitte
-

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Selvini-Palazzoli	Ipotesi scissione mente-corpo nell'anoressia	1963
Bruch	"La gabbia d'oro" — anoressia come malattia borghese; falso sé	1978
Devereux	Disturbi etnici / Culture-Bound Syndromes	1978
Cosenza	Quattro epoche storiche del sintomo anoressico	2008
Pope	Prima descrizione della "anoressia inversa" (vigoressia)	1993
Niola	"Homo dieteticus" — tribù alimentari	2015
Riva	Ortoressia/vigoressia e identità femminile post-COVID	2022
APA / DSM-5	Classificazione DNA; BED come entità autonoma	2013/2023
Sontag	"Malattia come metafora" — malattie simbolo di un'epoca	1978
Dalla Ragione	Intolleranze auto-diagnosticate come fattore di rischio DCA	2008

Parole Chiave

DNA · anoressia nervosa · bulimia nervosa · BED · ortoressia · vigoressia · Muscle Dysmorphia · disturbo etnico · Culture-Bound Syndrome · fattore patoplastico · separazione-individuazione · falso sé · dispercezione corporea · fattori predisponenti · fattori precipitanti · fattori cronicizzanti · siti pro-ana · DSM-5-TR